

TEMA 1.13 • CIRUGÍA GENERAL Y ANESTESIA

Patología Benigna de Mama

PERFIL EUNACOM 1.03.3.004

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Patología Benigna de Mama

La inmensa mayoría de las masas mamarias palpables en mujeres premenopáusicas corresponden a entidades completamente benignas que de ninguna manera tienen potencial oncogénico metastatizante.

1. Fibroadenoma (El Tumor Benigno más Frecuente)

- **Epidemiología:** Tumores mamarios sólidos más frecuentes. Aparición predominante en pacientes jóvenes (década de los 20s y 30s). - **Clínica Palpatoria:** Nódulo macizo, de bordes netos indolores. Su consistencia es clásicamente gomosa-firme (elástica, no pétreo). El signo patognomónico cardinal es que es y baila de forma **extremadamente móvil** libre de su base bajo el estroma cutáneo. - **Diagnóstico:** Dado el decil de edad de su prevalencia, el examen gold standard inicial **no** es la mamografía, sino que arranca de entrada con la **Ecografía Mamaria de Elección**. Su imagen revela un nódulo ovalado delimitado, de bordes lisos, con cápsula ecogénica visible y homogéneo. - **Conducta:** Si está asintomático sin alteraciones masivas de su tasa de crecimiento, la indicación rotunda por regla actual en pacientes <40 años es la exclusiva **Observación de evolución estricta** (Controles con Ecografía semestral por un transcurso preventivo de 2 años). La exéresis quirúrgica solo se reserva ante un dolor intratable severo y rápido crecimiento deformador.

2. Quiste Simple Mamario

- **Clínica y características:** Nódulo fluctuante y maleable, cuya tensión y engrosamiento puede variar cíclicamente a lo largo de las semanas y del estado presurizado del dolor de la cápsula pre-estrogénica. A la palpación resulta de bordes nítidos. - **Manejo Investigativo:** Frente a un quiste de agua simple, la confirmación absoluta se corrobora dictaminando en **Ecografía** hallazgos anecoicos redondos (burbuja de líquido negro) sin ecos vasculares ni murallas sólidas. - **Alternativa - Punción Aspirativa PAAF Diag-Terapéutica:** Si cursa como un gran foco de dolor quístico a inmensa tensión, se autoriza punción con aguja fina de vaciado. Si lo drenado y absorbido consta de fluido acuoso tintado blanquecino/verde oscuro libre, finaliza el drama como quiste crónico puro. (*Excepción para desconfiar en Pabellón: Retorno aspirativo sanguinolento/hemorrágico rutilante*).

3. Mastopatía Fibroquística (MFQ) o Enfermedad Fibroquística

Representa con creces el trastorno estructural proliferativa de patología benigna más incidente del humano adulto femenino general reproductivo. Es una respuesta alterada de las unidades lobulillares mamarias terminales a los perfiles reincidentes del ciclo ovulatorio estrogénico. - **Epidemiología:** Alta prevalencia en mujeres peri-menopáusicas. Se erradica y "sana" espontáneamente de inmediato cuando se alcanza la **menopausia** senil real, marcando fin a la disfunción dependiente de estrógenos de fondo. - **Clínica Clásica Sintomática:** Destacan por ser intensamente **mastálgicas**, manifestándose con abultamientos simétricos irregulares (granulosos, cuerdas cordón-fibróticas) bilaterales multiquísticos o placa fibroquímica premenstrual dolorosa masiva. - **Evaluación Típica:** Frecuentemente derivarán en confusos puntajes de informe radiológico **BI-RADS 0** producto de las inescrutables mamas tan densas escleróticas blancas al lente de

la máquina rayo. Requieren destrabarse sí o sí mediante una **Ecografía complementaria** visualizando el sembradío difusos de múltiples chispas micro quísticas dispersas entre tabiques engrosados duros. - **Conducta Definitiva:** Asegurarle tranquilamente médica que la MFQ jamás se cancerizará ni encierra mal pronóstico. Para su cuadro álgido recurrente central se utilizan como escudo a base de antiinflamatorios (Elección **AINEs - Ácido Mefenámico** o Paracetamol rotativo sintomatológico premenstrual reglado hasta su desaparición atrófica menopáusica).

Mastalgia Per Se

El dolor del parénquima de senos en su infinita multiplicidad (mastalgia). - Lo fundamental epidemiológicamente hablando es saber transmitir que **casi estadísticamente la Mastalgia o Dolor por sí sólo NO suele ser una manifestación sintomática de Cáncer de Mama**, estando este último habituado a debutar de formas crónicas silenciosas macizas induradas asintomáticas en cuadrantes lejanos. - Derivado más regularmente en el **Dolor Mamario Premenstrual Cíclico Simple**, cuyo tratamiento pilar reside meramente en la correcta anamnesis del médico integral sumado al apoyo moral con AINE respectivo.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Una mujer de veinticinco años consulta por un nódulo mamario derecho de un centímetro, gomoso, muy móvil, de bordes regulares. No tiene antecedentes familiares de cáncer. ¿Cuál es el diagnóstico probable y la conducta?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Patología Benigna de Mama. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- El fibroadenoma es el tumor benigno de mama más frecuente; ocurre en mujeres jóvenes; es un nódulo gomoso y muy móvil; el diagnóstico es con ecografía mamaria, no mamografía.
- El seguimiento del fibroadenoma es ecografía cada seis meses por dos años para descartar carcinoma filoides; en mujeres mayores de cuarenta años se agrega mamografía.
- El quiste simple se diagnostica con ecografía o punción con aguja fina; si el líquido es hemático o no sale líquido, hay que pedir mamografía para descartar cáncer.
- La mastopatía fibroquística es la patología mamaria benigna más frecuente; produce mastalgia premenstrual y mamas fibrosas con múltiples quistes; se diagnostica con ecografía.
- El tratamiento de la mastopatía fibroquística es educación de que no es cáncer ni se transforma en cáncer, se resuelve con la menopausia, y AINEs como ácido mefenámico para el dolor.
- La mastalgia premenstrual es la causa más frecuente de dolor mamario en mujeres jóvenes sin alteración al examen físico; no es síntoma de cáncer.
- El control mamográfico anual está indicado en la mastopatía fibroquística; si la mamografía sale BIRADS cero por mamas densas, se reemplaza por ecografía.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (PATOLOGÍA BENIGNA DE MAMA)**PREGUNTA 1**

Una mujer de veinticinco años consulta por un nódulo mamario derecho de un centímetro, gomoso, muy móvil, de bordes regulares. No tiene antecedentes familiares de cáncer. ¿Cuál es el diagnóstico probable y la conducta?

- A) Probable cáncer de mama; mamografía y biopsia urgente
- B) Fibroadenoma; ecografía mamaria y seguimiento ecográfico cada seis meses por dos años
- C) Fibroadenoma; mamografía y biopsia histológica inmediata
- D) Quiste simple; punción con aguja fina de urgencia
- E) Mastopatía fibroquística; ácido mefenámico y control en un año

PREGUNTA 2

Una mujer de cuarenta años consulta por un nódulo mamario de bordes lisos que duele al presionarlo. Se realiza punción con aguja fina que extrae líquido hemático. ¿Cuál es la conducta?

- A) Tranquilizar porque el líquido confirma que es un quiste benigno
- B) Mamografía para descartar cáncer
- C) Observación y control en seis meses
- D) Biopsia quirúrgica inmediata sin más exámenes
- E) Ecografía mamaria y si muestra quiste, alta sin más estudios

PREGUNTA 3

Una mujer de cuarenta y dos años consulta por dolor mamario bilateral que empeora los días previos a la menstruación. Al examen se palpan múltiples nódulos pequeños bilaterales. ¿Cuál es el diagnóstico, el examen y el tratamiento?

- A) Fibroadenoma bilateral; ecografía; observación
- B) Mastopatía fibroquística; ecografía mamaria; educación más ácido mefenámico
- C) Cáncer de mama bilateral; mamografía y biopsia urgente
- D) Mastopatía fibroquística; mamografía; mastectomía bilateral preventiva
- E) Quistes simples múltiples; punción de todos los quistes; antibióticos

RESUMEN: PATOLOGÍA BENIGNA DE MAMA

La patología benigna de mama incluye el fibroadenoma, el quiste simple, la mastopatía fibroquística y la mastalgia. El fibroadenoma es el tumor benigno de mama más frecuente, típico de mujeres jóvenes entre veinte y treinta años. Clínicamente es un nódulo de consistencia gomosa y muy móvil. El diagnóstico es con ecografía mamaria, que muestra un tumor sólido, bien delimitado, homogéneo y con cápsula. No se requiere mamografía en mujeres jóvenes con clínica típica de fibroadenoma. La conducta es seguimiento ecográfico cada seis meses por dos años para descartar el raro carcinoma filoides que puede simular un fibroadenoma. El quiste simple de mama se presenta con un nódulo de bordes lisos y consistencia variable. El diagnóstico es con ecografía, que muestra lesión quística, o con punción con aguja fina que extrae líquido no hemático. Si el contenido es hemático o no sale líquido, hay que pedir mamografía para descartar cáncer. La conducta es observación. Si hay dolor o gran tamaño, se puede puncionar, pero la recidiva es frecuente. La mastopatía fibroquística es la patología mamaria benigna más frecuente. Se presenta en mujeres adultas con mastalgia premenstrual y mamas fibrosas con múltiples quistes pequeños al examen. El diagnóstico es con ecografía mamaria. El tratamiento es educación, ya que no es cáncer ni se transforma en cáncer, y se resuelve con la menopausia, más AINEs como ácido mefenámico para el dolor. La mastalgia o dolor mamario puede ser premenstrual, que es la causa más frecuente en mujeres jóvenes sin alteración al examen físico, o secundaria a mastopatía fibroquística. El manejo es educación, AINEs y control mamográfico anual. La mastalgia no es síntoma de cáncer.